

Mảnh Ghép Niêm Mạc Má

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · mảnh ghép từ má dùng để tái tạo niệu đạo hoặc niệu quản

Trong phẫu thuật tái tạo, bác sĩ sẽ lấy một mảnh nhỏ lớp niêm mạc ẩm từ bên trong má — gọi là mảnh ghép niêm mạc má — để tái tạo niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài), hoặc đôi khi là niệu quản (ống nối thận với bàng quang). Tờ thông tin này giải thích tại sao dùng má, quy trình thực hiện, và cảm giác ở miệng sau phẫu thuật.

Về Mảnh Ghép Này

Lớp lót bên trong má là mô ẩm, dai, rất phù hợp với đường tiết niệu. Bác sĩ lấy một mảnh hình bầu dục mỏng từ một bên má (đôi khi cả hai bên nếu cần ghép dài hơn) để mở rộng hoặc tái tạo đoạn hẹp. Mảnh ghép được lấy **trong khi bạn đang ngủ mê, cùng lúc với phẫu thuật chính**.

Tại sao dùng niêm mạc má?

- Không có lông và quen với môi trường ẩm, giống như đường tiết niệu
- Dai, lành nhanh, ít để lại sẹo và có khả năng kháng nhiễm trùng tốt
- Lấy trong cùng một ca mổ — không cần thêm vết cắt, không để lại sẹo nhìn thấy

Có An Toàn Không?

Có. Lấy mảnh ghép niêm mạc má là kỹ thuật đã được áp dụng lâu dài, bệnh nhân thường chịu đựng tốt và mức độ hài lòng rất cao. Bác sĩ luôn tránh ống dẫn nước bọt và góc miệng. Phần lớn ảnh hưởng chỉ ở miệng — đau nhức, căng hoặc tê — và thường giảm trong vài tuần đầu. Lấy ghép cả hai bên má gây đau hơn, nên chỉ thực hiện khi cần sửa chữa đoạn dài hơn.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niêm mạc má (buccal mucosa)

Lớp lót ẩm bên trong má.

Mảnh ghép (graft)

Mảnh mô của chính bạn được chuyển sang để sửa chữa vùng khác.

Niệu đạo (urethra)

Ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể.

Tạo hình niệu đạo (urethroplasty)

Phẫu thuật sửa chữa hoặc tái tạo niệu đạo; mảnh ghép niêm mạc má là một phần của nó.

Vị trí lấy mảnh ghép (donor site)

Nơi lấy mảnh ghép — ở đây là bên trong má.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ sâu và không đau trong suốt ca mổ.

Ống dẫn nước bọt (parotid duct)

Lỗ nhỏ bên trong má dẫn nước bọt; bác sĩ tránh không chạm vào.

Cứng hàm (trismus)

Tạm thời khó há miệng rộng; giảm khi tập duỗi miệng nhẹ nhàng.

CÓ ĐAU KHÔNG? Mảnh ghép được lấy trong khi bạn ngủ mê dưới gây mê toàn thân, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, má sẽ đau nhức — giống như cắn phải má hoặc loét miệng — và có thể căng hoặc tê. Cơn đau giảm dần trong 1–2 tuần đầu, và má tiếp tục lành trong những tuần tiếp theo. Hầu hết bệnh nhân uống được nước trong vòng một ngày và ăn bình thường trong vòng một tuần.

Cách Chuẩn Bị (Trước Phẫu Thuật)

- Mảnh ghép được lấy trong ca phẫu thuật tái tạo của bạn, **dưới gây mê toàn thân** — hãy tuân thủ các hướng dẫn phẫu thuật thông thường (nhịn ăn và thuốc cần ngừng).
- Chăm sóc miệng** trước mổ — đánh răng và súc miệng sạch; nhóm bác sĩ có thể yêu cầu bạn làm sạch răng trước.
- Không hút thuốc, vape hay dùng thuốc lá** — điều này làm chậm lành miệng và mảnh ghép. Ngừng trước phẫu thuật rất có lợi.

Hãy báo cho nhóm bác sĩ trước nếu bạn:

- Đã từng phẫu thuật miệng, má, hoặc hàm, hoặc xạ trị vùng đầu cổ
- Có bệnh ở miệng, hoặc khó há miệng rộng
- Nhai thuốc lá hay trầu cau, hoặc có vấn đề răng miệng đang điều trị

Quá Trình Phẫu Thuật

- Bạn ngủ mê hoàn toàn dưới gây mê toàn thân trong suốt ca mổ, miệng được giữ mở nhẹ nhàng.
- Bác sĩ lấy một mảnh lát hình bầu dục mỏng từ một bên má (cả hai bên nếu cần ghép dài hơn), tránh ống dẫn nước bọt và góc miệng.
- Mảnh ghép được định hình và dùng để mở rộng hoặc tái tạo đoạn hẹp của đường tiết niệu.
- Vết cắt ở má thường được để tự lành, hoặc khâu lại bằng chỉ tự tiêu.

Sau Phẫu Thuật (Chăm Sóc Miệng)

- Hồi phục theo hai giai đoạn:** đau nhức và căng **giảm trong 1–2 tuần đầu**, nhưng má tiếp tục lành khoảng một tháng, và **cảm giác tê có thể mất một tháng hoặc hơn** mới hết.
- Ăn **thức ăn mềm, nhạt** trong thời gian đầu; tránh đồ cay, chua, nóng, giòn và rượu bia. Súc miệng nhẹ nhàng sau khi ăn.
- Tập **há miệng** nhẹ nhàng mỗi ngày để giảm cảm giác căng. **Không có sẹo nhìn thấy** — vết lấy ghép nằm bên trong miệng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Chảy máu miệng nhiều hoặc kéo dài
- Đau miệng nặng hơn, sưng hoặc chảy mủ (nhiễm trùng)
- Không thể uống nước hoặc hoàn toàn không há miệng được

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Một mảnh nhỏ niêm mạc ẩm từ bên trong má dùng để tái tạo niệu đạo — không lông, lành tốt và không để lại sẹo nhìn thấy.
- Mảnh ghép được lấy trong khi bạn ngủ mê, cùng lúc sửa chữa niệu đạo. Hãy nhịn ăn theo hướng dẫn, chăm sóc miệng trước mổ và không hút thuốc.
- Má sẽ đau, căng hoặc tê — **cải thiện trong 1–2 tuần nhưng lành hoàn toàn sau một tháng hoặc hơn**. Ăn mềm, súc miệng nhẹ, tập há miệng mỗi ngày. Gọi cho bác sĩ nếu sốt, chảy máu nhiều hoặc sưng lan rộng.